Guide pratique du thérapeute

Une médiation artistique, relationnelle et psychoéducative en psychiatrie et pédopsychiatrie.

Public : enfants, adolescents et adultes, en psychiatrie, pédopsychiatrie ou psychothérapie.

Durée indicative : 10 à 30 minutes, adaptable.

Objectif : proposer une expérience créative pour faciliter la rencontre, soutenir l'expression et explorer certaines habiletés psychosociales.

Inspirée du squiggle de Winnicott, Haïkuarelle invite le patient à composer avec les chants d'oiseaux, l'eau, les pigments et l'imprévisible.

> L'œuvre n'est ni un test ni un support d'interprétation diagnostique.

1. La posture du thérapeute

Observer → Accueillir → Relancer → Relier.

Le thérapeute accompagne sans diriger. Il peut intervenir lorsqu'une réaction, une émotion ou une initiative apparaît.

Il privilégie les questions ouvertes, les commentaires descriptifs et les silences.

Une relance n'est jamais obligatoire.

2. Le guide des relances

Ce qui se passe	Relance possible	Ce que l'on peut explorer
Le patient hésite	« On peut essayer, juste pour voir. »	Confiance, initiative
Il veut tout maîtriser	« Qu'est-ce que tu aimerais contrôler, et qu'est-ce que tu pourrais laisser évoluer ? »	Contrôle, incertitude
Il semble frustré	« Ce n'est pas ce que tu attendais ? »	Frustration, émotions
Il veut recommencer	« Qu'est-ce que tu aimerais faire autrement ? »	Ajustement, flexibilité
Il s'impatiente	« Qu'est-ce qui change si on laisse un peu de temps ? »	Attente, temporalité
Il se dévalorise	« Y a-t-il quelque chose que tu as aimé faire ? »	Rapport à soi, estime de soi
Il reste silencieux	« On peut simplement regarder ensemble. »	Présence, relation
Il manifeste du plaisir	« Qu'est-ce qui te plaît particulièrement ? »	Ressources, émotions positives
Il imagine une histoire	« Qu'est-ce que cela t'évoque ? »	Imaginaire, symbolisation
Il sollicite beaucoup d'aide	« Tu préfères qu'on cherche ensemble ou que tu essaies d'abord ? »	Autonomie, alliance
Il refuse une proposition	« D'accord. Comment préfères-tu faire ? »	Choix, affirmation de soi
Il est surpris par le résultat	« Qu'est-ce que cette surprise te donne envie de faire ? »	Curiosité, créativité

> Attention : ces situations n'indiquent pas à elles seules un fonctionnement psychologique particulier. Elles constituent des points d'appui possibles pour le dialogue.

3. Les cinq moments de la médiation

Moment	Relance simple	Intérêt possible
Écouter les chants	« Qu'est-ce qui attire ton attention ? »	Attention sensorielle
Créer avec les pigments	« Qu'as-tu envie d'essayer ? »	Initiative et pouvoir d'agir
Laisser évoluer la peinture	« Qu'est-ce qui te surprend ? »	Incertitude et adaptation
Rencontrer le haïku	« Ces mots t'évoquent quelque chose ? »	Imaginaire et symbolisation
Partager l'expérience	« Qu'aimerais-tu retenir de ce moment ? »	Expression et appropriation

Le thérapeute adapte le langage, la durée et le niveau de sollicitation à l'âge, aux capacités et à l'état clinique du patient.

4. Les six ressources psychosociales

La médiation peut ouvrir un travail autour de six dimensions, sans chercher à les mesurer.

Ressource	Expérience proposée
Oser	Essayer sans garantie de réussite
Choisir	Décider et agir sur son environnement
Ressentir	Reconnaître ses réactions et ses émotions
S'ajuster	Composer avec l'imprévisible
Patienter	Expérimenter l'attente et la transformation
Exprimer	Donner une forme sensible ou symbolique à son expérience

> Ces ressources ne sont pas des résultats thérapeutiques garantis. Elles représentent des possibilités de travail clinique.

5. Le débriefing en trois questions

À la fin de l'expérience, trois questions suffisent :

1. Le vécu : « Comment as-tu vécu ce moment ? »

2. La surprise : « Qu'est-ce qui t'a surpris ou marqué ? »

3. La résonance : « Est-ce que cela te fait penser à quelque chose dans ta vie ? »

> La troisième question est facultative. Le patient peut préférer ne pas verbaliser.

6. Quelques précautions cliniques

- Ne pas interpréter les couleurs, les formes ou les choix esthétiques comme des signes diagnostiques.
- Respecter le silence, le refus de participer et le rythme du patient.
- Adapter les stimulations sonores et visuelles aux sensibilités individuelles.
- Éviter de provoquer volontairement une frustration pour observer une réaction.
- Accueillir les émotions difficiles sans chercher à les transformer immédiatement en apprentissage.
- Ne pas assimiler le plaisir de créer à une amélioration clinique démontrée.

7. Après la séance : trois repères pour le thérapeute

Sans score ni grille standardisée, le professionnel peut retenir :

Ce qui a émergé : un geste, une parole, une émotion, une interaction.

Ce qui a fait rencontre : un moment de partage, de surprise, de plaisir ou de difficulté.

Ce qui pourrait être prolongé : une ressource, une question ou une expérience à reprendre en séance.

Le principe fondateur

Haïkuarelle n'est pas une épreuve pour révéler le fonctionnement du patient. C'est une expérience artistique partagée qui peut ouvrir des espaces d'expression, de relation et de découverte de soi.

Le thérapeute ne cherche pas à décoder l'œuvre. Il accompagne ce qui se vit autour d'elle.

La médiation conserve ainsi trois fonctions complémentaires : brise-glace relationnel, espace de créativité et support psychoéducatif.

Une création de Pierre-Henri Garnier •°○